

CAPÍTULO 11.6

Síndrome Hemolítico Urémico (SHU)

PERFIL EUNACOM 1.06.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Nefrología Clase 6 — Pendiente

> **Nota:** El transcripto de esta clase está dañado en la fuente. Este artículo será completado cuando se disponga del archivo correcto.

Estado: Pendiente de actualización.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 3 años con diarrea con sangre hace 5 días presenta oliguria, palidez, edema palpebral y presión arterial elevada. Hemograma: Hb 7 g/dL, plaquetas 45.000/mm³, creatinina 4.5 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Hemolítico Urémico (SHU). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SHU: causa importante de IRA renal en niños. Causa principal: E. coli O157:H7 (verotoxina/toxina Shiga).
- Edad más frecuente: 2-5 años. El 70% tiene antecedente de diarrea (disentérica o acuosa).
- Tríada: IRA grave + anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia. Frecuentes síntomas neurológicos.
- Diagnóstico: hemograma (anemia + plaquetopenia) + función renal + clínica.
- Tratamiento: soporte. El 90% revierte completamente. Diálisis de urgencia si síndrome urémico establecido.
- Diferencial con IRA prerrenal: SHU tiene anemia (no hemoconcentración), plaquetopenia, HTA y edema.
- Ictericia en contexto de diarrea + falla renal en niño orienta fuertemente a SHU.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU))

PREGUNTA 1

Niño de 3 años con diarrea con sangre hace 5 días presenta oliguria, palidez, edema palpebral y presión arterial elevada. Hemograma: Hb 7 g/dL, plaquetas 45.000/mm³, creatinina 4.5 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Deshidratación severa con IRA prerrenal
- B) Síndrome hemolítico urémico
- C) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- D) Púrpura trombocitopénica idiopática
- E) Sepsis por E. coli con falla multiorgánica

PREGUNTA 2

En un niño con SHU confirmado, creatinina de 6 mg/dL y compromiso de conciencia, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- A) Antibióticos de amplio espectro y observar
- B) Plasmaféresis de urgencia
- C) Soporte en UCI y diálisis de urgencia
- D) Hidratación endovenosa agresiva y esperar respuesta
- E) Transfusión de plaquetas de urgencia

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes hallazgos diferencia mejor el SHU de una IRA prerrenal en un niño con diarrea y oliguria?

- A) Nivel de creatinina sérica
- B) Presencia de anemia con plaquetopenia
- C) Presencia de oliguria
- D) Antecedente de diarrea
- E) Edad del paciente

RESUMEN: SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)

El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una de las causas más importantes de insuficiencia renal aguda en niños de tipo renal. Su causa principal es la infección por *E. coli* enterohemorrágica (O157:H7), que produce verotoxina o toxina Shiga. También puede ser causado por *Shigella* o *Mycoplasma*. La clínica típica es un niño de 2-5 años con antecedente de diarrea (70% disintérica o acuosa) que presenta insuficiencia renal aguda grave, anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y síntomas neurológicos. La fisiopatología es una microangiopatía por acción de la toxina sobre los vasos sanguíneos pequeños. El diagnóstico se hace con hemograma (anemia hemolítica y plaquetopenia) más exámenes de función renal más clínica. El tratamiento es de soporte, con diálisis de urgencia si hay síndrome urémico establecido. Hasta un 90% revierte por completo. Es clave diferenciar el SHU de la IRA prerrenal por deshidratación: en el SHU hay anemia, plaquetopenia, hipertensión y edema, mientras que en la prerrenal hay hemoconcentración, trombocitosis, hipotensión y deshidratación.